

Mga Pagpipilian Bago ang Prolapse Repair Surgery

Impormasyon para sa Pasyente · Mga desisyong pag-usapan sa inyong siruhano

WARWIKI

Kung isinasaalang-alang ninyo ang operasyon para sa pelvic organ prolapse (pagbaba ng organ sa loob ng puki), maraming pagpipilian na dapat pag-usapan kasama ang inyong siruhano. **Walang iisang “tamang” sagot** — ang pinakamainam na plano ay nakasalalay sa inyong anatomy, kalusugan, at kung ano ang pinakamahalagang bagay para sa inyo. Tinutulungan kayo ng papel na ito na maunawaan ang mga pangunahing desisyon.

Mga Pangunahing Desisyon

- **Pagpapaayos o pagsasara** — muling buuin ang suporta (reconstructive) at panatilihin ang bukang puki (vagina), o isara ang puki (colpocleisis) kung hindi na kayo nagpaplanong magkaroon ng pakikipagtalik sa puki.
- **Ruta** — sa pamamagitan ng vaginal approach (vagina) o abdominal approach (tiyan) gamit ang keyhole/robotic surgery.
- **Ang inyong matris (uterus)** — alisin ito (hysterectomy) o panatilihin gamit ang uterus-sparing suspension (hysteropexy).
- **Materyales para sa suporta** — sariling tisyu (native tissue), biological graft, o mesh (abdominal mesh tulad ng sa sacrocolpopexy).
- **Pagtagas ng ihi** — kung dapat bang magdagdag ng anti-leakage procedure ngayon (tingnan sa ibaba).

Tungkol sa Nakatagong Pagtagas

Minsan, ang malaking prolapse ay **nagtatago** ng stress incontinence (pagtagas ng ihi kapag may diin) na lumalabas lamang pagkatapos maayos ang prolapse (“occult” SUI). Maaaring subukan ito ng inyong care team at talakayin kung dapat bang magdagdag ng sling sa parehong operasyon o maghintay muna.

MGA TERMINO

Reconstructive

Muling pagbuo ng suporta at pagpapanatili ng vagina.

Obliterative

Pagsasara ng vagina (colpocleisis) — matibay, ngunit tinatapos ang pakikipagtalik.

Hysteropexy

Uterus-sparing suspension — pinapanatili ang matris.

Native-tissue repair

Pagpapaayos gamit lamang ang sariling tisyu, walang graft.

Occult SUI

Nakatagong pagtagas ng ihi na lumalabas pagkatapos maayos ang prolapse.

Recurrence

Posibilidad na bumalik ang prolapse sa paglipas ng panahon.

PAANO AKO PIPILI? Sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga pagpipilian sa **inyong** mga priyoridad — tibay, oras ng pagbawi, pagpapanatili ng matris, sekswal na aktibidad, at kung paano kayo nararamdaman tungkol sa mesh. Irerekomenda ng inyong siruhano ang angkop para sa inyong anatomy at kalusugan; ang “pinakamainam” na pagpipilian ay ang nakatugma sa inyong mga layunin matapos ang malinaw na talakayan.

Mga Tanong na Dapat Itanong sa Inyong Siruhano

- Aling **procedure(s)** ang inirerekomenda ninyo para sa akin, at bakit?
- **Vaginal o abdominal** approach — at ano ang hitsura ng pagbawi para sa bawat isa?
- Maaari ba (o dapat bang) **panatilihin ang aking matris**?
- Gagamit ba kayo ng **sariling tisyu, graft, o mesh** — at ano ang mga panganib?
- Kailangan ko ba ng **anti-leakage** procedure ngayon o mamaya?
- Gaano kalaki ang posibilidad ng **recurrence**, at ano ang gagawin kung bumalik ito?

Mabuting Malaman Din

- Ang **pessary** ay laging isang non-surgical na alternatibo kung nais ninyong maiwasan o ipagpaliban ang operasyon.
- Ang pag-optimize ng timbang, konstipasyon (paninigas ng dumi), ubo, at (pagkatapos ng menopause) vaginal estrogen ay makakatulong sa mga resulta.

Paano Maghanda

- Kumpletuhin ang lahat ng **pre-op na pagsusuri** at magdala ng listahan ng inyong mga gamot.
- Planuhing **tumigil sa paninigarilyo** at mag-ayos ng tulong sa bahay.
- Tandaan ang pangkalahatang tuntunin sa pagbawi: iwasan ang mabigat na pagbubuhat at pakikipagtalik nang humigit-kumulang 6 na linggo.

Sabihin sa inyong care team bago ang operasyon kung kayo ay:

- Umiinom ng **blood thinner** o may problema sa pagdurugo
- May kasalukuyang impeksiyon (infection) sa ihi o vagina
- May bagong sakit sa puson, pagdurugo, o hindi gumagaling na sugat sa bukol

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang prolapse surgery ay may ilang pagpipilian — pagpapaayos o pagsasara, ruta, pagpapanatili ng matris, materyales ng suporta, at paggamot ng nakatagong pagtagas.
2. Bihirang may iisang tamang sagot; ang pinakamainam na plano ay nagtutugma sa inyong anatomy at mga priyoridad.
3. Itanong ang mahahalagang tanong, at tandaang ang pessary ay laging isang non-surgical na alternatibo.